Traumeel®

FIMS2026
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Santiago de Chile - Chile

Traumeel® y el abordaje integral del esguince lateral de tobillo

De la inflamación a la resolución dentro del concepto de *soft tissue engineering*



Profesor Ludger Gerdesmeyer
Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica,
Universidad de Schleswig-Holstein, Alemania.

"Es solo un esguince de tobillo". Con esta frase, el Prof. Ludger Gerdesmeyer abrió una conferencia orientada a cuestionar la aparente simplicidad de una de las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes. Su punto de partida fue clínico: incluso en deportistas de alto rendimiento, una recuperación incompleta puede traducirse en pérdida de desempeño, recurrencias y dificultad para regresar al nivel previo. Por eso, planteó que el tratamiento debe adaptarse a las demandas de cada paciente y acompañarse de un programa de rehabilitación individualizado.

El eje conceptual de la presentación fue el *soft tissue engineering*: entender el esguince como una lesión de tejidos blandos que requiere integrar diferentes componentes, en lugar de aplicar un único protocolo. Gerdesmeyer incluyó el manejo del edema y la inflamación, la carga según tolerancia, el entrenamiento motor y propioceptivo, el *stretching* tendinoso, el drenaje linfático y, según el caso, otras herramientas físicas. Traumeel®/Tr14 gel fue presentado como un "*team player*" dentro de esta estrategia integral, y no como una intervención aislada.

Resolución de la inflamación: concepto presentado en la conferencia

CUADRO 1

Momento	Elemento destacado	Concepto
Respuesta aguda	Neutrófilos	La respuesta inicial forma parte del proceso inflamatorio
Resolución	SPM: lipoxinas, resolvinas, protectinas y maresinas	Participan en la fase de resolución
Tr14	Apoyo de vías pro-resolutivas	Presentado como apoyo a la resolución, en contraste con el bloqueo de la cascada

Adaptado de la presentación del Prof. Ludger Gerdesmeyer en el 39th FIMS World Congress of Sport Medicine, realizado en Santiago, Chile.

Una parte central de la conferencia estuvo dedicada a diferenciar el bloqueo de la inflamación del apoyo a su resolución. Gerdesmeyer describió la resolución como un proceso endógeno en el que intervienen mediadores especializados pro-resolutivos (SPM), mencionando lipoxinas, resolvinas, protectinas y maresinas. En su explicación, la respuesta neutrofílica inicial participa en la posterior generación de señales necesarias para completar la resolución. En este marco presentó a Tr14 como una formulación que no busca suprimir esa cascada, sino apoyar las vías asociadas con la resolución y la biosíntesis de mediadores pro-resolutivos.[1]

El recorrido de evidencia clínica comenzó con TAASS, ensayo multicéntrico publicado en 2013 que comparó la aplicación tópica de Traumeel® con diclofenac en el esguince agudo de tobillo. En la conferencia, se destacó la no inferioridad frente al comparador. A continuación, presentó TRAUMED, publicado en 2024: un ensayo prospectivo, multicéntrico, doble ciego y aleatorizado, que incluyó 625 pacientes y comparó Tr14 gel, placebo y diclofenac durante una semana de tratamiento y otra de observación.[1,2]

El criterio principal de valoración de TRAUMED fue el dolor durante el movimiento pasivo, evaluado mediante la escala visual analógica (EVA). Entre los criterios de valoración secundarios se incluyeron el dolor en reposo, la función, el tiempo hasta alcanzar al menos un 50% de reducción del dolor, el uso de medicación de rescate y la seguridad.[3] Gerdesmeyer mostró una reducción del dolor favorable a Tr14 frente a placebo y resultados de no inferioridad frente a diclofenac, con diferencias favorables en evaluaciones posteriores. La función se evaluó mediante cuestionario *Foot and Ankle Ability Measure* (FAAM). Destacó que el 50% de reducción del dolor con movimiento se alcanzó aproximadamente un día antes con Tr14 que con placebo o diclofenac; para dolor en reposo, señaló una diferencia de aproximadamente dos días. Resumió que, al día 7, los puntajes de dolor fueron 22 con Tr14, 34 con diclofenac y 40 con placebo.[3]

Finalmente presentó el metanálisis que integra los datos individuales de TAASS y TRAUMED. Según las diapositivas y su explicación, ambos ensayos mostraron resultados en la misma dirección, y el análisis combinado favoreció a Tr14 frente a diclofenac en los días 4, 7 y 14. La presentación destacó, además, una reducción del 50% del dolor aproximadamente 1.5 días más rápida con Tr14 en el análisis combinado.[4]

El cierre volvió al concepto inicial: el tratamiento del esguince no se reduce a una única herramienta. Para Gerdesmeyer, Tr14 debe entenderse como parte de una "orquesta" terapéutica integrada a la rehabilitación y al manejo global del tejido blando. También explicitó una limitación de TRAUMED: el seguimiento fue de 14 días, por lo que los efectos a más largo plazo requieren mayor investigación.[3]

TRAUMED: diseño y resultados destacados por el disertante

CUADRO **2**

Aspecto	Presentado en la conferencia
Diseño	Prospectivo, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado; Tr14 gel vs. placebo y diclofenac
Pacientes	625 casos
Tratamiento/observación	7 días + 7 días
Dolor al día 7	Tr14: 22 | diclofenac: 34 | placebo: 40
50% de reducción del dolor con movimiento	≈1 día antes con Tr14
Dolor en reposo	≈2 días de diferencia a favor de Tr14
Limitación señalada	Seguimiento total de 14 días

Adaptado de la presentación del Prof. Ludger Gerdesmeyer en el 39th FIMS World Congress of Sport Medicine, realizado en Santiago, Chile.

Metanálisis TAASS + TRAUMED

CUADRO 3

Hallazgo	Mensaje presentado
Datos integrados	Datos individuales de TAASS y TRAUMED
Dolor	Diferencia a favor de Tr14 en días 4, 7 y 14
Consistencia	Ambos ensayos mostraron resultados en la misma dirección
50% de reducción del dolor	≈1.5 días más rápido a favor de Tr14
Aplicación clínica	Esguince lateral de tobillo grado I–II

Adaptado de la presentación del Prof. Ludger Gerdesmeyer en el 39th FIMS World Congress of Sport Medicine, realizado en Santiago, Chile.



Conclusiones: 5 puntos finales

1. El esguince lateral de tobillo requiere un abordaje individualizado; la recuperación no se limita al alivio del dolor.
2. El *soft tissue engineering* integra tratamiento local, rehabilitación, carga según tolerancia y entrenamiento motor y propioceptivo.
3. La conferencia diferencia bloqueo de la inflamación de apoyo a su resolución y presenta a Tr14 dentro de una estrategia pro-resolutiva.[1]
4. TAASS y TRAUMED constituyen la base clínica presentada; TRAUMED incluyó 625 pacientes y evaluó dolor, función, tiempo hasta 50% de mejoría y seguridad.[1,2]
5. El metanálisis de TAASS + TRAUMED mostró resultados en la misma dirección y diferencias a favor de Tr14 frente a diclofenac en días 4, 7 y 14; el disertante propone integrarlo como un "*team player*" dentro del abordaje global.[4]

Referencias

1. Jordan PM, van Goethem E, Müller AM, et al. The natural combination medicine Traumeel (Tr14) improves resolution of inflammation by promoting the biosynthesis of specialized pro-resolving mediators. Pharmaceuticals (Basel). 2021;14(11):1123. doi:10.3390/ph14111123. **2.** González de Vega C, Speed C, Wolfarth B, et al. Traumeel vs. diclofenac for reducing pain and improving ankle mobility after acute ankle sprain: a multicentre, randomised, blinded, controlled and non-inferiority trial. Int J Clin Pract. 2013;67(10):979–989. **3.** Gerdesmeyer L, Vester J, Schneider C, et al. Topical treatment is effective and safe for acute ankle sprains: the multi-center double-blind randomized placebo-controlled TRAUMED Trial. J Clin Med. 2024;13(3):841. **4.** Vester J, Gerdesmeyer L, Kerkhoffs G. Tr14 gel compared to diclofenac gel after acute unilateral ankle sprain: an Individual Patient Data (IPD) meta-analysis of two multi-center trials. BMC Musculoskelet Disord. 2026;27(1):372.

CIRCLE PRESS

Revista de divulgación científica, de distribución gratuita y dirigida a profesionales de la salud.
Resumen elaborado por el staff médico de Circle Press.

El contenido de este trabajo representa un análisis, revisión bibliográfica y síntesis editorial. Los conceptos y las conclusiones pertenecen a los autores, y no reflejan las opiniones o recomendaciones del laboratorio patrocinante. La información resumida puede ser preliminar y estar sujeta a cambios. Los datos presentados se incluyen solo para la capacitación del médico, y la información tiene fines exclusivamente educativos.

-Heel

Traumeel® s

- **Resuelve** la inflamación [1,2,3]
- **Repara** el tejido [1,2,3]
- **Reduce** significativamente el dolor [1,4,5]

SIN LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS TRATAMIENTOS CONVENCIONALES:[5]

NO produce gastritis

NO aumenta riesgo cardiovascular

NO afecta el hígado ni el riñon



HECHO 100% -Heel ALEMANIA

3 Tómelo VECES AL DÍA SUBLINGUAL mañana - tarde - noche

Consulte aquí referencias bibliográficas, contraindicaciones y advertencias

*Material exclusivo para el cuerpo médico. Prohibida su reproducción divulgación como pieza publicitaría al público.

-Heel
Healthcare designed by nature